Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cruz Alta

Rua Voluntários da Pátria, 714 - Bairro: Ludke - CEP: 98005-104 - Fone: (55) 3029-9957 - Email: frcruzalta1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006174-76.2022.8.21.0011/RS

AUTOR: ALBERTINA MARIA RUBIN MAGRO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ALBERTINA MARIA RUBIN MAGRO ajuizou **Ação de Obrigação de Fazer** contra **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ/SAÚDE**, ambos qualificados. Aduziu, em síntese, que é acometida de leucemia mielóide aguda (CID 10 C92.0) e que se encontra hospitalizada para tratamento de quadro agudo da doença, já tendo realizado tratamento quimioterápico com a medicação "Citarabina", indicada pelos protocolos da demanda, mas sem resposta satisfatória. Aseverou que em decorrência da rápida evolução do quadro clínico e ausência de resposta do tratamento anterior, o médico assistente substituiu o tratamento, receituando o emprego das medicações VENETOCLAX, AZACITIDINA e NAUSEDRON. Aduziu que é conveniada ao IPê-SAÚDE, mas que ao solicitar o fármaco na via administrativa, teve seu pedido negado, em decorrência de instrução normativa. Ressaltou a urgência no fornecimento no medicamento, diante das chances de piora do quadro e evolução para óbito. Discorreu sobre o direio aplicável. Pugnou, em tutela de urgência, a determinação do requerido ao fornecimento do medicamento. Requereu a procedência da ação para condenar o requerido a fornecer o tratamento pugnando em tutela de urgência. Vindicou a justiça gratuita. Juntou documentos (evento 1).

Solicitada nota técnica (evento 3), a parte autora manifestou a urgência no fornecimento do medicamento (evento 6).

Foi acostada nota técnica (evento 8).

Sobreveio decisão recebendo a inicial, concedendo a justiça gratuita à autora e deferindo o pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos postulados (evento 10).

Citado, o requerido contestou o feito. Aduziu, em síntese, que possui protocolo oncológico próprio, sendo que o medicamento postulado na inicial não se enquadra no rol de recomendações técnicas adotado, e que o fornecimento de fármacos fora da lista não é possível, já que a assistência à saúde do IPE é organizada por lei e com fornecimento de fármacos e tratamentos determinados. Teceu comentários sobre a diferença entre os planos de saúde privados e públicos. Advertiu acerca da sustentabilidade do fundo de assistência à saúde. Asseverou sobre o tratamento de leucemia mielóide agudo no âmbito do IPE-SAÚDE, aduzindo que a procedência do pedido não é a garantia de um direito individual, mas a gradual dilapidação dos recursos do Fundo de Assistência à Saúde, colocando em risco toda a coletividade de beneficiários, preocupação inclusive do CNJ, citando diversos enunciados. Requereu a improcedência da ação (evento 26).

Houve réplica (evento 31).

Intimadas para dizerem sobre o interesse na produção de provas (evento 37), nada foi requerido.

Em parecer final, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido formulado na inicial (evento 46).

Sem mais, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, registro que o pedido do evento 36 refoge aos limites de julgamento da presente lide, que prevê tão somente pedido cominatório de fornecimento da medicação e não eventual ressarcimento. Aliás, o que sequer seria possível, considerando que o deferimento da liminar se deu 08/09/2022 e o período da conta hospitalizar, informada nos documentos acostados, é 25/08/2022 a 04/09/2022. Pelo exposto, deixo de determinar providências em relação ao postulado no referido evento.

É caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que a questão é eminentemente de direito e, no que se refere aos fatos, já estão devidamente comprovados nos autos com os documentos que foram juntados pelas partes.

Assim, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, bem como não havendo questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora requer a condenação do réu ao fornecimento de medicamento para tratamento da moléstia que lhe acomete.

É incontroverso nos autos que a autora é filiada ao Ipê-Saúde, assim como que acometida de leucemia mielóide aguda (CID 10 C92.0), seja pelos documentos que acompanham a inicial, como também pela ausência de insurgência pelo requerido.

O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, *caput*, da Constituição de 1988, com aplicação imediata, se tratando de um direito de todos e de dever do Estado (art. 196 da CF/88).

No mesmo sentido, o texto constitucional do Estado do Rio Grande do Sul prevê que:

Art. 41-A. O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)

Parágrafo único. O órgão ou a entidade de que trata o "caput" poderá, mediante a devida contrapartida, baseada em cálculo atuarial que assegure o equilíbrio financeiro, verificado anualmente mediante revisão dos termos contratuais, firmar contrato para a prestação de cobertura assistencial à saúde, na forma da lei, aos servidores, empregados ou filiados, e seus dependentes, das: (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)

I - entidades ou dos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta da União, do Estado e dos municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)

II - entidades de registro e fiscalização profissional, inclusive as de natureza autárquica "sui generis". (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)

Conforme assentado pelo requerido, o plano de saúde Ipê-Saúde, de fato, é instituído pela Lei Complementar n° 15.145/18, que reorganizou o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, sendo administrado por uma Autarquia Estadual, a qual obedece aos parâmetros expostos pela referida legislação para a concessão de coberturas.

O artigo 4ª da referida Lei Complementar, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que:

Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

§ 3º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.

Nesses termos, com base no parágrafo 1º, em tese, ficariam excluídos da cobertura do Ipê Saúde todos os tratamentos, exames, insumos, entre outros, que não estivessem previstos na tabela feita pelo próprio instituto.

Contudo, a ausência de previsão do medicamento no protocolo do demandado não pode ser suficiente para excluir o direito do autor ao medicamento prescrito pelo respectivo profissional como sendo o mais adequado ao seu caso. Caso assim fosse considerado, bastaria ao Plano de Saúde criar um protocolo restritivo, não incluindo o tratamento ao plano, a fim de reduzir sua responsabilidade.

Ademais, devemos lembrar que a evolução da medicina deve ser acompanhada pelos planos de saúde, de modo a contemplar os tratamentos mais modernos e melhores, como o presente caso.

Aliás, a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI), de modo que a ausência de previsão em tabela do IPE-SAÚDE não é o suficiente para negativa de autorização de tratamento indicado por médico credenciado.

No caso concreto, a conclusão emitida pela Nota Técnica, através do sistema NatJus, foi no sentido de que a utilização dos fármacos postulados para o quadro da autora é recomendado (evento 8, NOTATEC1). Vejamos:

Tecnologia: VENETOCLAX

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando o diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda;
Considerando que houve falha terapêutica na primeira linha de tratamento com antraciclina e citarabina;
Considerando que o uso da associação Venetoclax e Azacitidina está indicado para o tratamento da Leucemia Mielóide Aguda;
Considerando que existem estudos na literatura que respaldam esta indicação;
O parecer é favorável ao fornecimento das medicações pleiteadas Venetoclax e Azacitidina

Tecnologia: AZACITIDINA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando o diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda;
Considerando que houve falha terapêutica na primeira linha de tratamento com antraciclina e citarabina;
Considerando que o uso da associação Venetoclax e Azacitidina está indicado para o tratamento da Leucemia Mielóide Aguda;
Considerando que existem estudos na literatura que respaldam esta indicação;
O parecer é favorável ao fornecimento das medicações pleiteadas Venetoclax e Azacitidina

Tecnologia: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando o diagnóstico de LMA com indicação de tratamento quimioterápico;
Considerando os paraefeitos naúseas e vômitos comuns em pacientes em quimioterapia
Considerando que conforme a bula das medicação que serão utilizadas há indicação de pré medicação com antimético;
Considerando que a ondansetrona está indicada para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia;
Conclui-se que há subsídios para embasar o fornecimento da medicação pleiteada.

A referida conclusão vai ao encontro do laudo médico acostado à inicial (evento 1, ATESTMED7), que indica a necessidade do tratamento, sob pena de risco de morte do paciente pela progressão da doença, em decorrência da falha com a primeira linha de tratamento.

Nesse cenário, diante da indicação de que os fármacos trarão benefícios ao paciente, apresentando respostas satisfatórias no que diz respeito ao controle da doença, a previsão de exclusão do fornecimento do tratamento não deve ser aplicada.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul possui entendimento pacífico, inclusive em casos análogos, senão vejamos:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSIDERAÇÕES. 1. DO DIREITO AO TRATAMENTO. A necessidade do tratamento de saúde está comprovada nos autos, bem como a filiação da parte autora perante o IPÊ-SAÚDE. Subsunção, in casu, dos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar/RS n. 15.145/2018. 2. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais. 3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL. O argumento de que o tratamento não pode ser concedido em razão de não constar nos atos normativos editados pelo IPÊ-SAÚDE não prevalece diante do princípio constitucional da legalidade, pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, da CF/1988). A lei estadual não exclui a responsabilidade do plano de saúde de custear tratamento oncológico ao segurado, que contribui mensalmente para receber a assistência quando precisar. Limitações abusivas não prevalecem diante das normas constitucionais que garantem o direito à vida. 4. DO BLOQUEIO DE VALORES. Tratamento de saúde com custo elevado. Bloqueio de valores na conta do IPÊ-SAÚDE. Necessidade de três orçamentos. Observância daquele de menor valor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50013496620158210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 12-05-2023)*
>
> *APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) E AXITINIBE (INLYTA) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso da parte autora versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. O procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendeu à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15. Nesse contexto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, imperioso não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da Autarquia: Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50090431620218210021, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2022).*

Dessarte, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por ALBERTINA MARIA RUBIN MAGRO contra IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, para **confirmar** a tutela de urgência e **condenar** o requerido ao fornecimento à autora dos medicamentos **Venetoclax 100mg, Azacitidina 100mg e Cloridrato de Ondansetrona 8mg**, na posologia indicada no receituário e pelo tempo necessário ao tratamento.

Registra-se a obrigação da parte autora de fornecer, periodicamente, laudos médicos que comprovem a necessidade de continuidade do tratamento, inclusive para eventual pedido de cumprimento de sentença e bloqueio de valores.

O requerido é isento de custas processuais, diante da isenção concedida pelo art. 5º da Lei nº 14.634/2014.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), usando-se por analogia o art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista o valor do medicamento e por se tratar de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos (STJ - AgInt no AREsp 1568584/SP). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC a contar da presente sentença.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Interposta apelação por qualquer das partes ou recurso adesivo, considerando não haver mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, nos termos do art. 1.010, do CPC, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUANA SCHNEIDER, Juíza de Direito**, em 4/6/2023, às 11:14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10039616733v6** e o código CRC **1f1494c7**.